Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Judicial da Comarca de Lavras do Sul

Rua Julio de Castilhos, 373 - Bairro: Centro - CEP: 97390000 - Fone: (55)3029-9968 - (55) 997270282 - Email: frlavrsulvjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5000957-52.2022.8.21.0108/RS

AUTOR: RITA DE CASCIA SOARES MACHADO

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

1 - Relatório

RITA DE CASCIA SOARES MACHADO ajuizou "*ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência antecipada"* contra o **IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL**, todos qualificados na inicial, noticiando que é portadora da patologia: MELANOMA MALIGNO DA PELE, COM ESTÁGIO CLÍNICO IV, CID C43, necessitando incorporar ao tratamento os fármacos OPDIVO (Nivolumabe) 89mg EV no D1 e YERVOY (Ipilimumabe) 260mg EV no D1. Contudo, não possui condições financeiras de custear tal tratamento. Fundamentou os pedidos. Requereu, em tutela de urgência, que o réu fornecesse o tratamento postulado à doença que lhe acomete, na quantidade especificada, sob pena de multa diária. Pleiteou, ao final, a procedência da demanda para condenar o réu a fornecer o tratamento postulado, tornando definitiva a tutela de urgência. Pediu a gratuidade judiciária. Juntou documentos (evento 1, INIC1).

Recebida a inicial e deferida a tutela de urgência (evento 4, DESPADEC1). Deferida a gratuidade judiciária (evento 15, DESPADEC1).

O demandado informou o cumprimento da decisão (evento 20, OFIC3)

O requerido apresentou contestação (evento 30, CONT1), oportunidade em que sustentou que o IPÊ-Saúde não pode ser confundido com planos assistenciais privados, razão pela qual deve ser afastada a incidência do CDC, e a observância dos princípios que norteiam a administração pública, especialmente o princípio da legalidade. Discorreu acerca da necessidade de observar as tabelas oncológicas da instituição para a devida aferição dos medicamentos que podem ser utilizados, sob pena de afronta à legalidade, custeio, isonomia, e ofensa à separação dos poderes. Por fim, defendeu que os medicamentos da tabela oncológica são definidos como os que apresentam a melhor relação de custo x eficiência, requerendo assim a improcedência da demanda.

Houve réplica (evento 33, RÉPLICA1), oportunidade em que a parte autora rebateu todos os argumentos lançados na contestação, bem como reiterou os pedidos da exordial.

Instadas as partes quanto ao interesse na produção de provas (evento 35, DESPADEC1); A parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (evento 39, PET1). Por sua vez, o requeriso manifestou não haver interesse na produção de outras provas (evento 41, PET1).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

Em suma, é o relatório.

Fundamento e decido.

2 - Fundamentação

Tendo em vista que não houve requerimento de produção de outras provas, bem como considerando os termos da contestação, cabe o julgamento antecipado do feito, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Almeja a parte autora a condenação do réu ao fornecimento dos medicamentos OPDIVO (Nivolumabe) 89mg EV no D1 e YERVOY (Ipilimumabe) 260mg EV no D1, pois a doença está em estágio avançado que acarreta dores sginitifativas, além do risco de óbito, aduzindo ser portadora do *"CID C43 – melanoma maligno da pele, com estágio clínico IV, considerado avançado em virtude da disseminação em várias áreas do corpo"*.

O réu, por sua vez, nega a cobertura do medicamento solicitado pela parte autora, sob a alegação de não haver cobertura para o tratamento solicitado conforme protocolo de oncologia vigente. Contudo, razão não lhe assiste.

A Lei Complementar Estadual nº 15.145/18, que dispõe sobre o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE-Saúde, revogou expressamente a LC Estadual nº 12.134/04[1], trazendo inovações legislativas a respeito da temática.

Dispõe o artigo 4º da referida LC:

Art. 4º O Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE Saúde – consiste na cobertura das despesas decorrentes dos procedimentos previstos em tabelas próprias do Instituto para atendimento médico, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários, na forma estabelecida nesta Lei Complementar e em resoluções do Órgão Gestor.

§1º Ficam excluídos da cobertura do IPE Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos, materiais, que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto.

§2º Novos procedimentos somente poderão ser incluídos nas tabelas de cobertura do IPE Saúde após aprovação do Órgão Gestor, fundamentado em prévio cálculo financeiro e atuarial.

Ainda, os artigos 2º, 8º e 9°, da Resolução nº 21/79, do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul:

Art. 2º. O Plano de Assistência Médica destinado aos associados e seus dependentes cobrirá os atendimentos médicos hospitalares, bem como os atos necessários ao diagnóstico ou tratamento.

§ 1º. O Plano será restrito aos princípios da Medicina Curativa, sendo, no entanto, admissível em casos especiais a instituição de procedimentos preventivos.

Artº 8º - Incluem-se no Plano de Assistência Médica, em consonância com as respectivas normas, as seguintes especialidades: Anestesiologia, Angiologia, Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Geral, Ginecologia, Hematologia e Hemoterapia, Imunologia (Alergia), Medicina Nuclear, Nefrologia, Obstetrícia, Oftalmologia, Oncologia, Otorrinolaringologia, Patologia Clínica e Cirurgia, Pediatria, Plástica reparadora, Proctologia, Psiquiatria, Radiologia, Radioterapia, Reumatologia, Tisiopneomologia, Torácica, Traumatologia e Urologia.

Art. 9º. A assistência médico-hospitalar abrangerá os seguintes serviços:

1 – Emergências

2 – Consultas Médicas

3 – Serviços Complementares

4 – Tratamento Ambulatorial

5 – Tratamento Hospitalar

Os dispositivos legais mencionados demonstram a amplitude da cobertura, que abrange, inclusive, a realização dos exames necessários para o diagnóstico da paciente, proporcionando o tratamento de que necessita o segurado.

Por outro lado, denota-se do §1° do artigo 4° da LC 15.145/18 que os tratamentos não previstos nas tabelas próprias estariam excluídos da cobertura do plano de saúde

Contudo, na linha do atual entendimento da jurisprudência do nosso Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais, a circunstância de não existir previsão de cobertura no regulamento do IPE, em que pese o citado artigo 4°, §1°, não constitui motivo suficiente ao indeferimento do pedido, porque o critério que define a cobertura dos serviços de tratamento hospitalar oferecidos pelo Plano de Assistência Médica é o da exclusão expressa. Isso significa que apenas os procedimentos expressamente excluídos não são cobertos pelo sistema. Logo, em princípio, apenas os atendimentos psiquiátricos e as cirurgias plásticas estéticas e não estéticas são excluídas da cobertura, nos termos dos artigos 41 e 42, da Resolução nº 21/79[2].

Assim, absoluta a responsabilidade do réu pelo fornecimento de medicamento para o tratamento do melanoma, acaso demonstrada a necessidade do medicamento e a impossibilidade de substituição por outro. De maneira alguma é facultado ao plano de saúde negar o fornecimento do medicamento sob a justificativa deste não fazer parte da cobertura, pois não cabe ao IPE-Saúde selecionar o tratamento dispensado. Ademais, o direito constitucional à saúde não pode ser limitado a uma simples tabela ou protocolo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PLANO IPE-SAÚDE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE COPARTICIPAÇÃO. ÔNUS PROCESSUAIS E RESPECTIVOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1. A autora, portadora de "câncer de mama avançado ou metastático HR" (CID C 50.9), ajuizou o presente feito objetivando compelir o demandado à disponibilização do medicamento Palbociclibe 125, prescrito pelo profissional médico que a acompanha a fim de dar continuidade ao tratamento oncológico ao qual vem sendo submetida. 2. Não se há de admitir a negativa da autarquia demandada, sob o argumento de ausência de previsão de cobertura, pois o plano IPE-SAÚDE é integrado por atendimento médico, hospitalar e atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, bem como ações de prevenção de doenças e promoção da saúde, inclusive em área oncológica. Conquanto o artigo 4º da Lei Complementar n. 15.145/18, que revogou a Lei n. 12.134/04, disponha que integram o plano de saúde atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, laboratoriais, assim como atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos, exceto os tratamentos não previstos nas tabelas do próprio Instituto, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é cristalino quanto à impossibilidade do plano de saúde eleger as espécies de tratamento fornecidos ao segurado. Na situação em tela, restou cabalmente comprovada a necessidade de disponibilização do medicamento pleiteado, porquanto a autora tem apresentado progressão da doença enfrentada, não obstante já tenha sido submetida a tratamentos alternativos como quimioterapia, cirurgia, radioterapia e hormonioterapia. Prevalência da prescrição emitida pelo profissional médico que acompanha a paciente. 3. Ausência de amparo legal para a exigência de coparticipação sobre a dispensação de medicamentos. 4. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o Código de Processo Civil de 2015 fixou percentuais específicos para o arbitramento de honorários. No entanto, as ações relacionadas a medicamentos devem ser tratadas como de valor inestimável, pois os bens almejados são a vida e a saúde, e não apenas o fornecimento em si e o respectivo valor do fármaco, inexistindo acréscimo patrimonial em favor da parte autora. Sendo assim, a fixação dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8°, do Código de Processo Civil, para a hipótese contida nos autos, mostra-se mais adequada, não se havendo falar em proveito econômico para fins de justificar o arbitramento da verba com fulcro no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Posição deste órgão fracionário. Redução da verba honorária para patamar adotado por esta Câmara. Tanto antes do julgamento do Tema 1076 como depois, o entendimento do Tribunal da Cidadania vai direção de que, nas causas envolvendo tratamento de saúde, admite-se o juízo de equidade, no que diz com os honorários, porquanto o proveito econômico em tal situação é, em regra, inestimável. O valor fixado deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a contar da publicação deste acórdão, acrescido de juros moratórios pelos índices aplicados à caderneta de poupança, a contar do trânsito em julgado. Afastamento da condenação ao pagamento das despesas processuais. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 50019234820218210076, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 29-03-2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PALBOCICLIBE. NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DO IPE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO COMPROVADAS. DESCABE AO PLANO DE SAÚDE PÚBLICO SELECIONAR O TIPO DE MEDICAÇÃO NECESSÁRIA AO TRATAMENTO DO SEGURADO. A Lei Complementar nº 15.145/2018, que dispõe sobre o Plano de Saúde do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPE-SAÚDE), prevê a cobertura de atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, assim como os atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento da patologia de que padece o beneficiário. "Em que pese a edição da Lei Complementar nº. 15.145/2018, que altera a Lei Complementar nº. 12.066/2004, disciplinando que descabe a imposição ao IPERGS de medicamentos não previstos em seus regramentos, entendo que a falta de previsão no Protocolo Oncológico 2010 e o alto custo do medicamento não devem servir de obstáculo ao fornecimento do tratamento postulado, visto que demonstrada a necessidade do uso do fármaco, bem como a condição de segurada da autarquia. O Protocolo Oncológico aplicado pelo IPERGS se reporta ao ano de 2010, passados, pois, mais de sete anos, não tendo as orientações lá contidas pretensão de serem completas ou definitivas, sendo a atualização oncológica um fenômeno continuado que requer revisões frequentes." ("ut" trecho da ementa do Acórdão do Agravo de Instrumento Nº 70078464625). No caso concreto, restou demonstrada a urgência e a imprescindibilidade do fornecimento do medicamento postulado ao adequado tratamento da patologia que acomete a segurada. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROCURADOR PARTICULAR. REDUÇÃO. Verba arbitrada com observância dos vetores dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC e parâmetro adotado por esta Câmara em situações similares. APELO PROVIDO EM PARTE. (Apelação Cível, Nº 50004648720228210007, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 12-01-2023)

Dito isso, são verossímeis as alegações da autora, corroboradas por laudos e exames médicos evento 1, ATESTMED7 e evento 1, EXMMED6, pois o médico que atende a autora justificou a necessidade do uso do fármaco pleiteado, em virtude da patologia apresentada, MELANOMA DE COXA ESQUERDA, ESTADIO IV, COM MÚLTIPLAS LESÕES EM SUBCUTÂNEO E LINFONODOS, bem como da eficácia do medicamento - sobrevida global dos pacientes submetidos à combinação acima referida apresentaram sobrevida mediana maior de 60 meses - vejamos:

PACIENTE

RITA DE CASCIA SOARES MACHADO CPF: 361.961.000-25

Atestado Médico

LAUDO MÉDICO:

Paciente feminina, 57 anos, com diagnóstico recente de melanoma de coxa esquerda, Estadio IV, com múltiplas lesões em subcutâneo e linfonodos, documentadas em PET-CT 24.11.2022: Lesão nodular hipermetabólica no tecido adiposo extrapleural à direita ao nível do 7 espaço intercostal posterior, medindo 10 mm SUV 4.2. Linfonodos hipermetabólicos nas regiões inguinais bilateralmente à esquerda medindo 18 mm SUV 6,9 e à direita medindo 16 mm SUV 5.5 . Lesão expansiva nodular hipermetabólica no subcutâneo na região anterior e próxima da coxa esquerda com 77x64mm SUV 28.8. Há várias outras lesões nodulares no tecido subcutâneo distribuídas na mama direita, parede torácica à esquerda, região lombar direita, região glútea direita e no terço médio da perna esquerda, bem como entre os planos musculares da região próxima da coxa esquerda. Selecionadas as lesões no subcutâneo da mama direita com 10 mm SUV 4.8, região glútea à direita com 38x27 mm SUV 21.5 para futuros acompanhamentos.
Solicitou-se para paciente, devido ao contexto clínico acima, a combinação de ipilimumabe e nivolumabe, baseada na publicação dos dados de 5 anos de seguimento do estudo Checkmate 067, no ano de 2017 (N Engl J Med 2019; 381:1535-1546. DOI: 10.1056/NEJMoa1910836). Este estudo demonstrou que a sobrevida global dos pacientes submetidos à combinação acima referida apresentaram sobrevida mediana maior de 60 meses enquanto que os grupos de pacientes que receberam nivolumabe e ipilimumabe isoladamente apresentaram sobrevida global de 36.9 meses e 19.9 meses, respectivamente. A sobrevida global em 5 anos foi de 52% no grupo de ipilimumabe e nivolumabe combinados, 44% no grupo com nivolumabe isolado e 26% no grupo com ipilimumabe isolado. O protocolo do IPERGS atual contempla terapias isoladas de imunoterapia com Anti-PD1; entretanto, face aos dados do estudo acima referido bem como recomendações de diretrizes nacionais e internacionais, optado por se solicitar a combinação. O tratamento combinado com ipilimumabe e nivolumabe está aprovado pela ANVISA e incorporados ao ROL de medicamentos da Agência Nacional de Saúde.
O protocolo consiste em 4 ciclos de nivolumabe 89mg EV (1mg/kg) no D1 e ipilimumabe 260 mg EV no D1 (3mg/kg), sendo que cada ciclo é administrado em intervalos de 21 dias. Após estes 4 ciclos iniciais de indução, mantém-se o tratamento com nivolumabe 260 mg EV (3 mg/kg) a cada 14 dias enquanto paciente apresentar boa tolerância e reposta ao tratamento.
O início das referidas medicações é de caráter urgente visto que paciente apresenta queixas álgicas significativas relacionadas ao melanoma primário bem como suas metástases.
O não uso da referida combinação, conforme dados acima relatados, aumenta o risco de óbito por parte da paciente.
CID C43

Outrossim, a urgência também é flagrante, considerando tratar-se de melanoma, cuja evolução sabe-se que é muito rápida, e postergar o tratamento pode levar à morte do paciente.

Além disso, não se pode olvidar do fato de que o médico que acompanha a autora tem plena convicção de qual fármaco se adapta melhor ao tratamento clínico em questão.

Por seu turno, não produziu o demandado prova capaz de contrapor ao atestado, no sentido de que a Autora poderia valer-se de outros tratamentos que não o postulado.

Nesse contexto, procede a presente demanda para, confirmando a tutela de urgência do evento 4, DESPADEC1 , determinar que o Réu forneça os medicamentos OPDIVO (Nivolumabe) 89mg EV no D1 e YERVOY (Ipilimumabe) 260mg EV no D1, conforme atestados médicos, para o tratamento contínuo e pelo tempo necessário, sob pena de ser determinado o sequestro de valores para a aquisição do medicamento (art. 538, §3º, c/c artigo 500, do Código de Processo Civil).

3 - Dispositivo

Ante o exposto, *confirmando a tutela de urgência do* evento 4, DESPADEC1, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo **PROCEDENTE** o pedido aduzido por **RITA DE CASCIA SOARES MACHADO** contra o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPE SAUDE,** para condenar o Réu a fornecer os medicamentos OPDIVO (Nivolumabe) 89mg EV no D1 e YERVOY

(Ipilimumabe) 260mg EV no D1, de acordo e na quantia indicada nos atestados juntados ao feito, para o tratamento contínuo e pelo tempo necessário, sob pena de ser determinado o sequestro de valores do demandado para aquisição do medicamento (art. 538, §3º, do Código de Processo Civil).

Eventual alteração de dosagem da medicação, no curso do tratamento e após reavaliações, se dará por mera comprovação, mediante laudo médico, administrativamente e/ou nos autos se houver recalcitrância do Réu em disponibilizar os fármacos, cujo cumprimento de sentença (seja o provisório, seja o definitivo) se dará por meio da tutela específica de bloqueio de valores, com posterior prestação de contas, diante da necessidade da efetividade da jurisdição, na forma do artigo 497, *caput,* e artigo 536, §1º, do CPC.

Caberá a parte Autora, de forma periódica e na via administrativa, comprovar a necessidade da medicação, com prescrição médica atualizada.

Isento o requerido do pagamento da taxa única (art. 5°, inciso I, da Lei nº 14.634/2014), cabendo-lhe o pagamento integral das despesas processuais, se houver (arts. 14 e 16 da Lei nº 14.634/2014). Condeno o demandado, ainda, ao pagamendo dos honorários advocatícios em favor do procurador da parte autora, na forma do artigo 85, § 2°, do CPC, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Sentença registrada e publicada eletronicamente, da qual vão as partes intimadas via sistema Eproc.

Interposta apelação, processe-se, conforme os trâmites legais e, após, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Com o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **AMANDA RODRIGUES DA GAMA, Juíza de Direito**, em 25/10/2023, às 0:14:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10048607979v12** e o código CRC **9b62f6d5**.

---

1. Art. 48. Fica revogada a Lei Complementar nº 12.134, de 26 de julho de 2004. ↩
2. Art. 41. Não serão admitidas baixas hospitalares para atendimentos psiquiátricos, especialmente os casos crônicos.Art. 42. Não serão admitidas baixas hospitalares para cirurgias plásticas estéticas ou não éticas. ↩